

	IMPRESIÓN DE HISTORIA CLÍNICA PSICOLOGÍA	
	Historia # 00001	Fecha De Impresión: 17-03-2026 08:33:19

Datos Personales							
Nombre:	JHON JAIRO PEDROZO DIAZ	Sexo Biológ.:	H	F. Nacimiento:	2002-03-19	Edad	23 Años, 11 Meses, Y 29 Días
Identificación:	CC - 1003233871	Lateralidad:	Zurdo	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	OFICIALJHONPEDROZO@GMAIL.COM - 1003233871			Dirección:	CALLE 9B #22-72 IRACAL		
Departamento:	CESAR		Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		MARTHA DIAZ MAESTRE - Parentesco (madre) - Teléfono (315 5706352)					

Apertura psicología del 2025-05-08 13:39:06: 23 años, 11 meses, y 29 días

DATOS GENERALES

Remisión Autorreferido (Particular)
DX principal F845 - SINDROME DE ASPERGER DX Relacionado 1 NREF - NO REFIERE DX Relacionado 2 NREF - NO REFIERE
Código de consulta 890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA
Motivo de Consulta Refiere el paciente, "No debi confersame con ella, es mi mejor amiga y ahora no quiere saber nada de mi" "me siento rechazado, triste, muy ansioso y frustrado" "Tengo ideas suicidas"
Enfermedad Actual El paciente acude a consulta por sintomatología emocional y conductual que ha presentado agudización hace un mes. Refiere ánimo deprimido, ansiedad generalizada, alteración del ciclo de sueño con insomnio, pensamientos recurrentes de carácter negativo y pesimista, sobrecarga cognitiva (sobrepensamiento), sensación de vacío y desesperanza, así como episodios de llanto frecuente y angustia emocional. Manifiesta presencia de ideas suicidas con planeación activa, además de antecedentes de conducta suicida a los 16 años mediante ingesta de lorazepam, lo cual requirió hospitalización en UCI durante 7 días. También reporta antecedentes de autolesiones mediante cortes a esa misma edad. El malestar actual se encuentra relacionado con un evento de tipo interpersonal —pérdida de una relación de amistad significativa tras un rechazo afectivo—, así como con conflictos familiares actuales. Refiere autolesión emocional (rumiación, autocrítica) y percepción paranoide ocasional. Diagnóstico previo de Trastorno del Espectro Autista, subtipo Síndrome de Asperger, establecido a los 8 años.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico Circuncisión	Tóxicos Sobre Ingesta De Lorazepam
Traumáticos Otro	Medicación No Refiere
Paraclínicos : Ecografías, Tomografías, Electroencefalograma.	Hospitalizaciones UCI
Patología No Refiere	

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión No Refiere	Ansiedad No Refiere
Demencia Abuela Paterna,Abuela Materna	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos Hipertensión, Diabetes	Otros Diálisis En Riñón, Problemas Cardiacos, Hiperatividad En El Papá.

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa

Actualmente cursa octavo semestre del programa de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Santander (UDES). Refiere mantener relaciones interpersonales funcionales con algunos compañeros, aunque también ha experimentado conflictos con otros, lo cual ha contribuido a dificultades en la adaptación al entorno académico. Presenta sensibilidad a estímulos ambientales como el ruido, situación que, junto con el ambiente social conflictivo, motivó la suspensión temporal de un semestre. Reporta relaciones positivas y cooperativas con el cuerpo docente.

Historia laboral

No refiere

Historia familiar

El paciente reside actualmente con su núcleo familiar conformado por el padre el señor Jhon Jairo Pedrozo Restrepo con 55 años, la madre la señora Martha Liliana Diaz Marin con 53 años y un hermano menor el joven Victor Manuel Pedrozo Diaz con 17 años. De acuerdo con la entrevista psicológica, se identifica una dinámica familiar caracterizada por la presencia de diálogo constante y disponibilidad de apoyo emocional por parte de los padres y el hermano, lo cual representa un factor protector en el entorno del paciente.

Historia social

El paciente refiere contar con un círculo social reducido, manteniendo relaciones cercanas y significativas con dos compañeros de la universidad. Se describe como una persona selectiva en sus vínculos interpersonales, con preferencia por espacios sociales estructurados. Participa de manera esporádica en celebraciones o festividades con sus amigos, lo cual reporta como experiencias gratificantes. Expresa interés y adherencia al ejercicio físico, particularmente al gimnasio, actividad que realiza con regularidad y que identifica como fuente de bienestar.

Historia emocional/afectiva

El paciente presenta un estilo de vinculación caracterizado por la selectividad en sus relaciones interpersonales. Mantiene vínculos afectivos significativos con un pequeño grupo de amigos universitarios, con quienes comparte espacios sociales en fechas o actividades puntuales. Se observa una adecuada capacidad para establecer relaciones cuando se encuentra en contextos percibidos como seguros o predecibles. Refiere antecedentes de dificultades afectivas recientes asociadas a una experiencia de rechazo sentimental, la cual ha generado un impacto emocional significativo, con exacerbación de síntomas depresivos. En el ámbito familiar, se identifica una red de apoyo estable, con presencia de diálogo y acompañamiento emocional por parte de los padres y el hermano menor. Estas relaciones familiares cumplen una función contenedora en momentos de crisis.

Historia deportiva

Entrena en Gimnasio en ocasiones.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Evaluación psicológica inicial

Se realizó entrevista clínica semiestructurada con el objetivo de explorar antecedentes personales, historia clínica y áreas funcionales del paciente. Durante la evaluación se identificó un proceso de acompañamiento psicológico y médico continuo durante la infancia, retomando en la actualidad únicamente el seguimiento en Psicología, lo cual ha permitido un monitoreo constante de su desarrollo emocional y conductual. Adicionalmente, se aplicó el Inventario de Depresión de Beck (BDI), en el cual el paciente obtuvo una puntuación alta, indicando la presencia de sintomatología depresiva significativa que requiere seguimiento e intervención clínica. La información obtenida orienta a la necesidad de mantener intervenciones adaptadas a sus características del neurodesarrollo, con enfoque en la contención emocional y el fortalecimiento de habilidades socioafectivas.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica

En la infancia, sin control actualmente.

Intervención neurológica

No refiere

Intervención neuropsicológica

En la infancia, sin control actualmente.

Otras intervenciones

No refiere

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

Paciente ingresa a consulta en compañía de los padres, con buen saludo, orientado alopsiquica y autopsiquicamente, consciente, euprosexico, con APA adecuada y abordable, estado de animo deprimido, llanto facil, no mantiene contacto visual, la memoria impresiona conservada, verborreico, labilidad afectiva, sin alucinaciones sensoperceptivas, juicio interferido, inteligencia imprisiona alta, atención conservada, consciente de la situación actual y motivado a recibir el tratamiento psicoterapeutico, con ideas suicidas y antecedente de intento suicida en la adolescencia.

Ciclos del Sueño

Alterados, interfieren los pensamientos intrusivos y rumiación.

Apetito

Alterado

Actividades de Autocuidado

Independiente, con supervisión en algunas actividades.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):

F845 - SINDROME DE ASPERGER

Impresión Diagnóstica Relacionada 1 F322 - EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS Impresión Diagnóstica Relacionada 2 NREF - NO REFIERE
Establecido por primera vez No
Objeto de atención clínica No refiere

PLAN DE INTERVENCIÓN
Plan de Intervención
Objetivo General Alcanzar una mejora en el estado emocional y reducir la distorsión cognitiva, a través de la gestión de la tristeza, el duelo y los sentimientos de culpa.
Objetivos Específicos *Proporcionar al paciente y familiares información específica acerca del diagnóstico, generando conciencia del mismo. *Identificar las distorsiones cognitivas, o pensamientos negativos (pesimistas), acerca de sí mismo, del mundo y del futuro, intervención desde ACT y TCC. *Trabajo con técnicas de regulación emocional y solución de problemas, para que el paciente logre definir y describir el problema, con la finalidad de disminuir los sentimientos de desesperanza, la culpa, fracaso y fortalecer la tolerancia a la frustración. *Cambiar el estado de ánimo del paciente, aumentando su autoestima, y su energía, mejorando los procesos cognitivos, disminuyendo el insomnio, la ansiedad y el estado de animo depresivo. *Realizar entrenamiento en técnicas de Mindfulness y relajación mental.
Sugerencias e Interconsultas • Interconsulta por Psiquiatría (Urgente)
Observaciones y Recomendaciones • Continuar con las Terapias por Psicología clínica Individual (2 veces por semana durante 4 semanas) • Hacer ejercicio físico de su preferencia mínimo 30 minutos y mantener la alimentación saludable.



DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542
Mag. TP3G - VIU

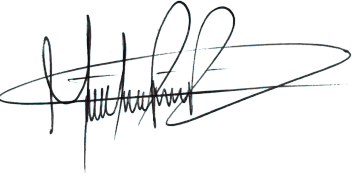
Datos Personales							
Nombre:	JHON JAIRO PEDROZO DIAZ	Sexo Biológ.:	H	F. Nacimiento:	2002-03-19	Edad	23 Años, 11 Meses, Y 29 Días
Identificación:	CC - 1003233871	Lateralidad:	Zurdo	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	OFICIALJHONPEDROZO@GMAIL.COM - 1003233871			Dirección:	CALLE 9B #22-72 IRACAL		
Departamento:	CESAR		Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		MARTHA DIAZ MAESTRE - Parentesco (madre) - Teléfono (315 5706352)					

Impresión Diagnóstica:
F845 - SINDROME DE ASPERGER

Impresión Diagnóstica Relacionada 1
F322 - EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS

Impresión Diagnóstica Relacionada 2
NREF - NO REFIERE

ÓRDENES MÉDICAS		
No.	PROCEDIMIENTO	CANTIDAD
1	890284 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA OBSERVACIÓN: Se recomienda Remisión A Valoración Por Psiquiatría Con El Fin De Realizar Evaluación Integral E Intervención Especializada Para El Manejo De Sintomatología Depresiva, Presencia De Ideación E Intento Suicida, Así Como Para La Regulación Del Sueño Y Del Estado De Ánimo.	1



DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542
Mag. TP3G - VIU



PRASCA
CENTER